

" S22: Douleurs thoraciques aiguës "

1. Une douleur thoracique peut correspondre à une atteinte :

- A. De l'aorte abdominale
- B. Du diaphragme
- C. De l'estomac
- D. Du thymus
- E. De l'œsophage

2. L'interrogatoire est un temps essentiel de la consultation pour douleur thoracique car

- A. Il permet de préciser le terrain.
- B. Permet de faciliter l'orientation diagnostique
- C. Peut être retardée si détresse vitale
- D. Le tableau peut être atypique chez les diabétiques.
- E. L'absence des facteurs de risque cardio-vasculaire justifie de ne pas faire un ECG

3. Devant une douleur thoracique aiguë :

- A. L'électrocardiogramme doit être réalisé dans les 10 premières minutes
- B. Il faut éliminer en priorité les urgences cardiovasculaires
- C. L'intensité de la douleur est souvent corrélée à la gravité de la pathologie sous-jacente
- D. Une radiographie thoracique doit être réalisée en urgence
- E. Une douleur aggravée par la palpation signe l'origine pariétale de la douleur

1) Les signes gravités devant une douleur thoracique aiguë sont :

- A. Un assourdissement des bruits du cœur
- B. Une tension artérielle différentielle pincée
- C. Une diminution inspiratoire du pouls radial
- D. Une fièvre >40° C en plateau
- E. Une Syncope

4. Devant une douleur thoracique associée à un état de choc et des signes droits, il faut

- A. Admettre le patient en USI et monitoring
- B. Réaliser un ECG 12 dérives
- C. Injection de morphine en sous cutané
- D. Administrer une dose de Natispray
- E. Un remplissage immédiat est indiqué

5. Une douleur thoracique angineuse est suspectée devant les signes suivants :

- A. Elle est de type brûlure
- B. Elle survient à l'effort
- C. Elle est brève
- D. Elle est de siège antérieur
- E. Elle est positionnelle
- F. Elle est soulagée par la prise de dérivé nitré en sublingual

6. Une douleur thoracique est suggestive d'une ischémie myocardique si :

- A. Elle s'aggrave à l'effort physique
- B. Elle cède progressivement en quelques minutes après l'arrêt de l'effort
- C. Il existe un souffle mitral systolique à l'examen physique
- D. Elle s'associe à des signes neurovégétatifs (nausées, vomissements, sudation profuse)
- E. Il existe un souffle d'insuffisance aortique

7. Devant une douleur thoracique, quels sont les signes évocateurs d'une origine pleurale ?

- A. Le caractère unilatéral de la douleur
- B. Le caractère constrictif de la douleur
- C. L'amélioration en position couchée
- D. L'augmentation des douleurs à la toux
- E. La variation de l'intensité de la douleur avec les mouvements respiratoires

8. La douleur thoracique est rythmée avec les mouvements respiratoires et la toux dans les situations suivantes :

- A. Une péricardite aiguë
- B. Un syndrome coronarien aigu
- C. Une pleurésie
- D. Une dissection de l'aorte
- E. Une embolie pulmonaire
- F. Névralgie intercostale

9. Une douleur thoracique survenant 1 semaine après un syndrome grippal doit faire évoquer :

- A. Une embolie pulmonaire
- B. Un syndrome coronarien aigu
- C. Un spasme oesophagien
- D. Une péricardite aiguë
- E. Une myocardite aiguë
- F. Une endocardite infectieuse

10. Une douleur thoracique type brûlure rétrosternale majorée par l'antéflexion est en faveur du diagnostic

- A. Syndrome coronarien aigu
- B. Dissection aortique
- C. Embolie pulmonaire
- D. Reflux gastro-oesophagien
- E. Péricardite aiguë

11. Une douleur thoracique aiguë en post partum doit évoquer :

- A. Une embolie pulmonaire
- B. Un syndrome coronarien aigu
- C. Une dissection de l'aorte
- D. Une péri-myocardopathie du post-partum
- E. Une endocardite infectieuse

12. La survenue d'une douleur thoracique aiguë chez un toxicomane à la cocaïne doit faire évoquer en premier lieu :

- A. Un spasme coronaire
- B. Une endocardite infectieuse
- C. Une embolie pulmonaire
- D. Une dissection de l'aorte
- E. Un pneumothorax

13. Une douleur thoracique aiguë associée à un tableau d'insuffisance cardiaque droite aiguë doit évoquer :

- A. Une myocardite aiguë
- B. Une embolie pulmonaire
- C. Un IDM inférieur compliqué d'EDC
- D. Une tamponnade péricardique
- E. Un pneumothorax bilatéral compressif

14. Devant une douleur thoracique avec hypotension et signes d'ICA droite et une auscultation pulmonaire normale, Vous suspectez en premier

- A. Un syndrome coronarien avec sus-décalage de ST et extension au ventricule droit
- B. Une crise d'asthme aigu grave
- C. Une embolie pulmonaire grave
- D. Une dissection aiguë compliquée d'une rupture dans le péricarde
- E. Une compression médiastinale d'origine tumorale

15. L'électrocardiogramme en cas de douleur thoracique :

- A. Est le premier examen complémentaire à réaliser
- B. Un ECG normal doit être refait si récurrence de la douleur
- C. Comporte 18 dérivations.
- D. Un bloc de branche gauche récent doit être considéré comme signe d'ischémie myocardique.
- E. Oriente vers une péricardite en cas de sus-décalage du segment PQ.

16. Les troponines peuvent être élevés en cas de :

- A. Pleurésie
- B. Péricardite
- C. Embolie pulmonaire
- D. Dissection de l'aorte
- E. Insuffisance rénale

17. Concernant les biomarqueurs en cas de douleur thoracique :

- A. Les troponines ont un intérêt pronostique dans la suspicion d'embolie pulmonaire.
- B. Les D-Dimères négatifs éliminent le diagnostic d'embolie pulmonaire
- C. Les D-Dimères peuvent être utiles pour éliminer une dissection de l'aorte
- D. En cas de négativité initiale des troponines US, le dosage doit être refait après 3 heures
- E. Les troponines ont un intérêt pronostic en cas de syndrome coronarien aigu

18. Les signes échographiques suivant sont en faveur de souffrance myocardique ischémique :

- A. dilatation du VD
- B. L'hypertension artérielle pulmonaire
- C. L'hyperkinésie globale
- D. Une hypokinésie segmentaire du VG
- E. Une rupture d'un pilier mitral

19. Les présentations cliniques atypiques des syndromes coronariens aigus sont particulièrement fréquentes chez :

- A. le sujet âgé
- B. les femmes
- C. les sujets jeunes < 40 ans
- D. le sujet insuffisant rénal
- E. les immunodéprimés

20. Un patient de 50 ans, consulte pour douleur thoracique, évoluant depuis 7 heures, le diagnostic d'infarctus de myocarde est évoqué devant :

- A. Une douleur constrictive.
- B. Siège rétro sternal
- B. Irradiation vers le dos
- D. Une douleur qui s'aggrave à l'effort
- E. Durée supérieure à 20 minutes.

21. L'examen physique et L'ECG sont normaux. Le taux initial de troponines US est normal à 9 ng/L (ULN < 14 ng/L). Indiquer la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le diagnostic d'infarctus du myocarde peut être éliminé
- B. Une origine coronaire à cette douleur thoracique peut être écartée
- C. Un dosage des troponines US après 3 heures est nécessaire
- D. Les étiologies non coronaires des douleurs thoraciques doivent être envisagées
- E. Un retour à domicile avec un Coro scanner à distance peut être indiqué

22. Les signes électriques en faveur d'un infarctus du myocarde :

- A. Un sous décalage descendant localisé dans un territoire coronarien.
- B. Un sus décalage convexe en haut localisé dans un territoire coronarien.
- C. La présence d'une onde q de nécrose
- D. Un bloc de branche droit récent
- E. Un sus décalage du segment PQ en AVR

23. Chez un patient ayant un SCA sans sus décalage du segment ST

- A. Une angioplastie coronaire immédiate est indiquée
- B. L'élévation des troponines confirme le diagnostic
- C. Une thrombolyse en urgence est indiquée si instabilité hémodynamique
- D. Une stratification du risque ischémique est nécessaire
- E. Le risque de mort subite est imminent

24. Quelles sont parmi ces propositions, les situations favorisant la survenue d'une embolie pulmonaire ?

- A. Alitement prolongé
- B. Insuffisance cardiaque congestive
- C. Insuffisance veineuse et varices
- D. Immobilisation plâtrée
- E. Postpartum
- F. Tabagisme
- G. Néoplasie
- H. Syndrome néphrotique
- I. Grossesse

25. Les signes cliniques en faveur d'une embolie pulmonaire sont

- A. Polypnée
- B. Syncope
- C. Hémoptysie
- D. Douleurs thoraciques de nature pleurale
- E. Un syndrome grippal

26. Les signes électriques en faveur d'une embolie pulmonaire sont

- A. Un bloc de branche droit
- B. Une fibrillation auriculaire
- C. Un QT allongé
- D. Un aspect S1Q3 avec un axe droit
- E. Ondes T négatives de V1 à V3

27. On peut retenir le diagnostic d'embolie pulmonaire par :

- A. Les D-dimères $> 500 \mu\text{g/l}$.
- B. L'angioscanner thoracique.
- C. La scintigraphie pulmonaire en cas de contre-indication au scanner injecté.
- D. Les signes échographiques de cœur pulmonaire aigu en cas d'état de choc.
- E. Un score de Wells > 6 .

28. L'instabilité hémodynamique dans l'EP est définie par:

- A. Un arrêt cardiaque
- B. Une hypotension persistante
- C. Une chute de la PAS > 40 mmHg durant plus de 15 min et non causée par une hypovolémie
- D. PAS < 90 mmHg durant plus de 10 min et non causée par un sepsis
- E. PAS < 90 mmHg

29. Une embolie pulmonaire est considérée d'emblée à haut risque devant la ou les situation (s) suivante (s)

- A. Hypotension artérielle persistante
- B. Troponine positive
- C. taux de BNP élevé
- D. Score PESI simplifié > 3
- E. Arrêt cardiaque récupéré

30. Concernant le score PESI dans l'embolie pulmonaire, quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s)?

- A. Evalue le risque de récurrence de l'embolie pulmonaire à 6 mois
- B. N'est pas recommandé chez les patients d'âge > 80 ans
- C. La version simplifiée sPESI attribue 1 point par facteur de risque présent
- D. Permet d'identifier les patients à faible risque
- E. Nécessite une échocardiographie pour être calculé

31. Concernant le dosage des D-Dimères en cas de suspicion d'une embolie pulmonaire :

- A. Sa négativité chez les patients à probabilité faible permet d'écarter le diagnostic.
- B. une forte valeur prédictive positive.
- B. Un premier dosage négatif doit être refait 6 heures après.
- C. Sa spécificité diminue avec l'âge du patient.
- E. Son taux diminue de façon progressive au cours de la grossesse.

32. Les D-dimères peuvent être en cas de :

- A. Sepsis sévère.
- B. Personnes âgées > 75 ans.
- C. Grossesse.
- D. Chirurgie récente.
- E. Péricardite aigue

33. Les circonstances à risque de dissection aortique sont :

- A. La maladie de Marfan
- B. Une cardiomyopathie dilatée
- C. Une HTA mal équilibrée
- D. La maladie d'Horton
- E. Un anévrisme de l'aorte

34. Une dissection aigue de l'aorte peut être favorisée par :

- A. Un syndrome coronarien aigu
- B. Syndrome de Turner
- C. Toxicomanie intraveineuse (Cocaïne, Amphétamines)
- D. Une grossesse
- E. Certaines maladies héréditaires du tissu élastique

35. La douleur thoracique d'une dissection aortique :

- A. Est le signe fonctionnel le plus fréquent
- B. Est de durée brève
- C. Est brutale
- D. A type de constriction ou de brûlure
- E. Peut être associée à une douleur des membres inférieurs
- F. Souvent migratrice
- G. Irradie vers la pointe du cœur
- H. Est associée à un souffle systolique au foyer aortique
- I. D'aggravation progressive

36. Devant une douleur thoracique, es signes cliniques associés en faveur du diagnostic d'une dissection aortique sont :

- A. Une hémiplégie
- B. Une syncope
- C. Une hypertension artérielle
- D. Une thrombose veineuse profonde
- E. Une insuffisance rénale aigue

37. Les signes cliniques en faveur d'une dissection aortique sont :

- A. Un souffle systolique récent au foyer aortique
- B. Une anisosphygmie
- C. Une anisotension
- D. Des râles crépitants
- E. Un bruit de Galop
- F. Un état de choc
- G. Un élargissement de la pression artérielle différentielle

38. Le signe radiologique évocateur d'une dissection aortique est :

- A. Un élargissement des espaces intercostaux
- B. Une cardiomégalie
- C. Une scissuriteUn élargissement médiastinal
- D. Un épanchement pleural

39. Le signe échographique caractéristique de la dissection aortique est :

- A. Une HVG
- B. Une bicuspidie aortique
- C. Un gradient systolique VG – Aorte
- D. Un flap intimal
- E. Une insuffisance aortique

40. Concernant le dosage des D-dimères dans la dissection aiguë de l'aorte, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A. Une valeur $> 500 \mu\text{g/L}$ permet de poser le diagnostic
- B. Une valeur normale ($< 500 \mu\text{g/L}$) exclut permet d'exclure le diagnostic
- C. Ils sont inutiles dans un contexte de faible suspicion clinique
- D. Leur dosage est recommandé chez des patients stables
- E. Ils permettent de différencier une dissection de type A d'une dissection de type B

41. Devant une forte suspicion clinique d'une dissection aortique avec instabilité hémodynamique :

- A. L'angioscanner thoracique est l'examen de première intention.
- B. L'échocardiographie transthoracique peut être réalisée en première intention au lit du patient.
- C. En cas de suspicion de dissection de type A, un avis chirurgical urgent est requis avant toute imagerie.
- D. L'échographie transœsophagienne est l'examen de choix en cas de suspicion de dissection de type A.
- E. Un traitement antihypertenseur doit être initié rapidement, même avant la confirmation par l'imagerie.

42. Au cours d'une dissection aortique, l'angioscanner aortique :

- A. Est réalisé sans injection de produit de contraste.
- B. Est indiqué en deuxième intention après l'ETO.
- C. Montre le faux chenal et les portes d'entrée et sortie.
- D. Montre l'extension de la dissection
- E. Doit couvrir au moins l'aorte thoracique.

43. Les examens qui peuvent confirmer une dissection aortique sont :

- A. Un angioscanner aortique
- B. Une échographie cardiaque trans-oesophagienne
- C. Un scanner thoracique
- D. Une échographie cardiaque trans-thoracique
- E. Une angio-IRM aortique

44. Les complications possibles de la dissection aortique sont :

- A. Une endocardite infectieuse
- B. Une tamponnade
- C. Une ischémie mésentérique
- D. Un AVC
- E. Un IDM

45. La dissection aigue de l'aorte de type B (selon la classification de De Bakey) :

- A. A un meilleur pronostic de la dissection de type A
- B. Constitue une urgence chirurgicale
- C. Peut être traitée médicalement
- D. Peut se compliquer d'une insuffisance aortique
- E. Peut se compliquer d'un hémopéricarde

46. La prise en charge d'une dissection aortique type A comporte :

- A. Un traitement anticoagulant pour prévenir les complications ischémiques.
- B. Un traitement antiagrégant pour prévenir une dissection coronaire.
- C. Un traitement antihypertenseur par voie orale en cas de chiffres tensionnels élevés
- D. Une chirurgie dans les 24 heures.
- E. Une hospitalisation en milieu de réanimation

47. Une douleur thoracique précordiale évoque le diagnostic de péricardite aiguë si :

- A. Elle est de type constrictif
- B. Elle est accentuée lors des mouvements respiratoires
- C. Elle est d'installation brutale
- D. Elle est associée à une tachycardie à 110 battements par minute
- E. Elle associée à une fièvre

48. Les signes électriques en faveur du diagnostic de tamponnade péricardique sont :

- A. Une alternance électrique
- B. Un sous décalage du segment PQ
- C. Un micro-voltage diffus
- D. Un sus-décalage de ST diffus
- E. Une rotation axiale droite

49. Les explorations de 1ere intention devant une forte suspicion de péricardite sont

- A. Electrocardiogramme
- B. Dosage des troponines et de la CRP
- C. Une échographie cardiaque transthoracique
- D. Une radiographie de thorax
- E. Dosage des CPK

50. Concernant les anomalies ECG au cours d'une la tamponnade cardiaque :

- A. La tachycardie sinusale est un signe constant
- B. Le microvoltage est un signe spécifique mais non sensible
- C. L'alternance électrique est pathognomonique mais rare
- D. Un bloc auriculoventriculaire complet est fréquent
- E. Les troubles de la conduction intraventriculaires orientent vers la sévérité de la tamponnade

51. La prise en charge d'une tamponnade comporte :

- A. Un remplissage
- B. Des dérivés nitrés à la pousse seringue électrique pour diminuer la précharge
- C. Des diurétiques pour forcer la diurèse et diminuer ainsi l'épanchement
- D. Des drogues vasoactives
- E. Un drainage péricardique dans les 24 heures

52. Cas clinique 1

Un patient de 34 ans, est transporté aux urgences pour une douleur thoracique. Cette douleur est survenue brutalement une heure auparavant. Le patient vous décrit cette précordialgie comme un « coup de poignard » partant dans la poitrine et irradiant dans le dos. Il n'existe aucun antécédent connu hormis une forte myopie. L'examen clinique retrouve une tension artérielle à 170/90 mm Hg, un pouls à 100 BPM et une apyrexie. La taille est de 1.95 m pour 71 kg. L'ECG est normal, hormis une tachycardie sinusale. Une dissection aortique est suspectée.

1) En faveur de ce diagnostic vous retenez :

- A. Le terrain
- B. Les caractéristiques de la douleur
- C. La normalité de l'électrocardiogramme
- D. La poussée hypertensive
- E. La tachycardie

2) Les éléments suivants de l'examen physique permettent de conforter ce diagnostic :

- A. Anisotension > 20 mm Hg
- B. Abolition d'un pouls fémoral
- C. Souffle diastolique au bord gauche du sternum
- D. Hyperpulsatilité artérielle
- E. Souffle systolique sur le trajet de la carotide interne gauche

3) La pathologie sous-jacente la plus probable serait :

- A. Une coarctation de l'aorte
- B. Une bicuspidie aortique
- C. Une maladie de Marfan D.
- D. Un syndrome de Turner
- E. Une toxicomanie

4) L'examen complémentaire à demander ici en première intention pour confirmer le diagnostic est :

- A. Un angioscanner thoracique
- B. Un dosage de D-Dimères
- C. Une échographie cardiaque transthoracique
- D. Une échographie cardiaque transoesophagienne sous sédation
- E. Une angio-IRM thoracique

53. Cas clinique 2

Patient âgé de 66 ans, hypertendu et diabétique, consulte aux urgences pour une douleur thoracique aiguë continue depuis 3 heures. Les douleurs sont décrites comme des brûlures rétrosternales et irradiant vers l'épaule gauche. A l'examen, la Pression artérielle est à 190/110 mm Hg, un pouls régulier à 100 BPM et une SpO2 : 98%. L'auscultation cardiaque et pulmonaire sont sans anomalies. L'ECG montre un bloc de branche gauche complet.

1) Les facteurs de risque cardiovasculaire retrouvés chez ce patient sont :

- A. L'âge
- B. L'hypertension artérielle
- C. Le diabète
- D. Le tabac
- E. L'absence d'hérédité cardiovasculaire

2) Les caractéristiques de cette douleur thoracique vous font évoquer :

- A. Une douleur péricardique
- B. Une douleur pleurale
- C. Une douleur aortique
- D. Une douleur angineuse
- E. Une douleur pariétale

3) Le diagnostic le plus probable serait :

- A. Un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage de ST
- B. Une dissection aortique
- C. Une embolie pulmonaire
- D. Une péricardite aiguë
- E. Un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST

4) La conduite à tenir que vous préconisez chez ce patient :

- A. Cycle de troponine US H3-H6
- B. Répéter ECG à H3-H6
- C. Dosage des D-Dimères
- D. Echographie cardiaque transthoracique au lit du patient
- E. Angiographie coronaire

54. Cas clinique 3

Un homme âgé de 30 ans, sans antécédents pathologiques notables, se présente aux urgences pour une douleur thoracique évoluant depuis deux jours, aggravée par le décubitus dorsal et la toux.

A l'examen : Température = 37,9° C, la fréquence cardiaque était à 90 bpm régulière, sa pression artérielle était 120/70 mmHg, les bruits du cœur étaient assourdis et il n'avait pas de signes d'insuffisance cardiaque.

A l'ECG : Rythme régulier sinusal, microvoltage diffus, pas de troubles de la repolarisation
A la biologie : GB= 15000 e/mm³, Hb= 13 g/dl, Plaquettes= 400000 e/mm³ CRP= 30 mg/l
Créatinine sanguine= 90 umol/l

1- Devant ce tableau, quel(s) diagnostic(s) est (sont) évoqué(s) en premier :

- A. Une péricardite aiguë
- B. Une tamponnade cardiaque
- C. Une embolie pulmonaire
- D. Un syndrome coronarien aigu
- E. Une dissection de l'aorte

2- Parmi ces examens complémentaires, le(s)quel(s) est (sont) indiqué(s) en 1ère intention pour confirmer le diagnostic :

- A. Une échocardiographie transthoracique
- B. Une échocardiographie transoesophagienne
- C. Un coroscanner
- D. Le dosage des BNP
- E. Le dosage des D-Dimères

3- Quel(s) est (sont) le(s) élément(s) de gravité chez ce patient :

- A. L'âge jeune
- B. La température à 37,9° C
- C. L'assourdissement des bruits du cœur à l'auscultation cardiaque
- D. Le microvoltage diffus à l'ECG
- E. Le syndrome inflammatoire biologique

55. Cas clinique 4

Patient âgé de 60 ans, tabagique et diabétique, consulte pour une douleur thoracique constrictive épigastrique, prolongée depuis 6 heures. Le diagnostic de syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST est suspecté et l'ECG a été réalisé.

Quelles sont les éléments de l'anamnèse en faveur de ce diagnostic

- A. Le caractère constrictif
- B. L'absence de signe associée
- C. Le caractère prolongé
- D. Le siège épigastrique
- E. Les antécédents

L'ECG doit être réalisé dans les 10 minutes du premier contact médical. Il doit comporter

- A. 12 dérivations
- B. DII long à la recherche de trouble du rythme
- C. 18 dérivations
- D. Les dérivations droites
- E. Les dérivations basales

Le diagnostic de syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST dans le territoire inférieur a été retenu. L'ECG dans ce cas peut montrer :

- A. Une onde T pointue ample et symétrique en antérieur
- B. Une onde Q de nécrose en DII DIII AVF
- C. Un sous-décalage de ST en V1V2V3
- D. Un sus-décalage de ST en DII DIII AVF
- E. Un sus-décalage de ST diffus et concave en haut

Juste après la réalisation de l'ECG, le patient a présenté une perte de conscience. L'examen trouve une pression artérielle imprenable et une bradycardie à 30 bpm. A l'ECG on a un bloc auriculo-ventriculaire complet

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Une tamponnade
- B. Une rupture de la paroi libre du VG
- C. Une insuffisance mitrale aiguë
- D. Un bloc auriculoventriculaire
- E. Une extension au ventricule droit

Quelle est votre conduite à tenir aux urgences

- A. La dobutamine à la seringue électrique
- B. Atropine en IVD
- C. Adrénaline à la seringue électrique
- D. Un pacing externe
- E. Isuprel à la seringue électrique